

☐ Strategi Penanganan Jika Semua Gejala Kunci Dijawab "YA" (Skenario Komorbiditas)

Fase	Aksi Sistem	Gejala yang Ditampilkan	Logika dan Tujuan
I. Kunci Awal	14 Pertanyaan Awal dijawab "Ya".	14 Gejala dengan CF ≥ 0.95 (G01, G02, G03, G12, G13, G14, G15, G23, G11, G24, G25, G35, G42, G43).	Tujuan: Semua 5 penyakit (P1-P5) terpicu sebagai kandidat diagnosis. Sistem mengkonfirmasi Gejala Inti Terkuat dari semua kategori.
II. Konfirmasi Berjenjang	Sistem menjalankan <i>forward chaining</i> terintegrasi.	1. Sisa Gejala CF ≥ 0.90: Tampilkan semua sisa gejala dengan bobot ≥ 0.90 yang belum ditanyakan (misalnya, G04, G2, G19, G32, G26, G27, G37, G36, G38, G44, G45). (Total ≈ 11 pertanyaan).	Tujuan: Mengumpulkan data konfirmasi sekunder (gejala berbobot tinggi) dari semua 5 penyakit untuk meningkatkan akurasi <i>score</i> CF awal.
II. Lanjutan (Pembeda)	Sistem melakukan <i>cross-checking</i> (pengecekan silang) pada gejala tumpang tindih.	2. Gejala Tumpang Tindih Kritis (CF 0.80 - 0.85): Tampilkan G05, G06, G16, G11 (Jika belum ditanyakan di Fase I/II), dan gejala lainnya yang dimiliki minimal oleh 3 penyakit.	Tujuan: Gejala ini sering menjadi faktor pembeda antar penyakit (misalnya, apakah Kantuk Berlebihan/G05 benar-benar ada). Ini memberikan input penting untuk perhitungan final.
III. Diagnosis Akhir	Perhitungan VCIRS & Certainty Factor	Semua 47 gejala (termasuk yang tidak ditampilkan/dijawab "Tidak" [CF[E]=0]).	Tujuan: Menghitung nilai CF gabungan untuk semua 5 penyakit. Diagnosis akan menunjukkan beberapa penyakit dengan persentase tinggi, menandakan kemungkinan Komorbiditas (Tumpang Tindih Diagnosis).